

Nomor : PM.01.01/C.III/2729/2025

13 Agustus 2025

Lampiran : satu berkas

Hal : Umpan Balik Capaian Indikator Pelibatan Jaringan
Rumah Sakit Swasta Besar (*Big Chain Hospitals*) dalam
Program Penanggulangan Tuberkulosis di
RS Muhammadiyah/Aisyiyah Triwulan 1 dan 2 Tahun 2025
per 1 Juli 2025

Yth. Ketua MPKU PP Muhammadiyah
Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Lantai 3
Jalan Menteng Raya No.62, DKI Jakarta

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penguatan Implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis telah dilakukan antara Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan dengan Manajemen Pusat Jaringan Rumah Sakit Swasta Besar (*Big Chain Hospitals*) pada 13 Juni dan 16 Desember 2022. Pada perjanjian tersebut terdapat sepuluh indikator sebagai tolok ukur progres dan keberhasilan intervensi.

Bersama ini, kami lampirkan umpan balik capaian indikator pelibatan Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Triwulan 1 dan 2 tahun 2025 (data olah SITB per 1 Juli 2025). Adapun kesimpulan dari capaian tersebut antara lain:

1. Indikator 1: jumlah temuan kasus TBC
Akumulasi capaian temuan/notifikasi kasus TBC di 106 RS Muhammadiyah/Aisyiyah adalah 6.531 kasus (45% dari target).
2. Indikator 2: angka keberhasilan pengobatan (TSR)
 - a. TSR Triwulan 1 dan 2 tahun 2025 = data kohort pengobatan TBC bulan Januari - Juni 2025.
 - b. Tahun 2025, capaian TSR akumulatif di 102 RS Muhammadiyah/Aisyiyah yaitu 76%, belum mencapai target yang telah ditentukan di tingkat nasional (TSR = 90%).
3. Indikator 3: persentase RS yang memiliki SK Tim TBC
 - a. SK Tim TBC yang terbaru menyesuaikan tim TBC yang sedang bertugas pada periode waktu yang sedang berjalan.
 - b. Tahun 2024 dan 2025, sebanyak 52 RS Muhammadiyah/Aisyiyah (48%) sudah memiliki SK Tim TBC.
 - c. Dibutuhkan informasi lebih lanjut terkait mapping RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang telah memiliki SK Tim TBC.
4. Indikator 4: persentase RS yang memiliki SPO tentang penanggulangan tuberkulosis
 - a. Capaian yang terhitung adalah SPO yang terupdate (minimal tahun 2021) sesuai SE Direktur Jenderal P2P nomor HK.02.02/III.1/936/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis TBC tahun 2021 dan penerapan jejaring internal dan eksternal di RS berdasarkan juknis DPPM tahun 2019 (memiliki ketiga SPO secara lengkap, jika belum lengkap maka tidak dihitung).
 - b. Tahun 2024 dan 2025, terdata sebanyak 28 RS Muhammadiyah/Aisyiyah (26%) sudah memiliki ketiga SPO yang ditentukan.
 - c. Dibutuhkan informasi lebih lanjut terkait mapping RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang telah memiliki SPO dengan lengkap.

5. Indikator 5: persentase RS yang melaporkan terduga TBC
100% RS Muhammadiyah/Aisyiyah (108 RS) sudah melaporkan terduga TBC.
6. Indikator 6: persentase RS yang melaporkan notifikasi/kasus TBC
98% RS Muhammadiyah/Aisyiyah (106 RS) sudah melaporkan notifikasi kasus TBC. Dua RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang belum tercatat menotifikasi kasus TBC tahun 2025 antara lain: RSIA PKU Muhammadiyah Cipondoh Kota Tangerang dan RS Jiwa Islam Klender Kota Jakarta Timur.
7. Indikator 7: persentase RS yang mengakses OAT program
92% RS (99 RS) sudah mengakses OAT program untuk pasien TBC.
8. Indikator 8: persentase RS yang mengakses TCM
97% RS Muhammadiyah/Aisyiyah (105 RS) sudah mengakses TCM untuk penegakan diagnosis TBC. Tiga RS yang belum tercatat mengakses TCM antara lain: RSIA 'Aisyiyah Samarinda, RS Jiwa Islam Klender Kota Jakarta Timur, dan RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo.
9. Indikator 9: persentase RS yang mendapatkan peningkatan kapasitas
 - a. Sebanyak 69 RS Muhammadiyah/Aisyiyah (64%) telah mendapatkan pelatihan/peningkatan kapasitas.
 - b. Dibutuhkan informasi lebih lanjut terkait mapping RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas.
10. Indikator 10: persentase RS yang mengintegrasikan SIMRS-SITB
35% jaringan RS Muhammadiyah/Aisyiyah (38 RS) telah melakukan integrasi.

Selain itu, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen pusat Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah antara lain:

1. Mendorong RS jaringan untuk melakukan intensifikasi skrining TBC sebagai upaya meningkatkan penemuan terduga TBC, mulai dari bagian administrasi/registrasi pasien di setiap unit sampai dengan di poli/unit layanan.
2. Mendorong RS jaringan untuk meningkatkan pemeriksaan follow-up/pemantauan pengobatan dengan mikroskopis, serta mengobati pasien hingga selesai. Selain itu, agar mengisi hasil akhir pengobatan pasien TBC (sembuh/pengobatan lengkap/lainnya). Sehingga, dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan di masing-masing RS.
3. Mendorong RS yang belum mengakses OAT program untuk dapat mengaksesnya melalui koordinasi dengan dinas kesehatan kab/kota di wilayah RS masing-masing.
4. Mengarahkan RS jaringan untuk memperbaharui SK Tim TBC di RS masing-masing menyesuaikan dengan tim yang sedang bertugas pada periode waktu berjalan.
5. Mengarahkan RS jaringan untuk memperbaharui Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait alur diagnosis TBC sesuai dengan alur terbaru tahun 2021 (diagnosis menggunakan TCM), jejaring internal, dan jejaring eksternal layanan TBC di RS.
6. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan terkait program TBC atau mendorong akses e-learning modul TBC di Plataran Sehat (<https://lms.kemkes.go.id/>) bagi tenaga kesehatan, khususnya yang tergabung dalam tim TBC di RS.
7. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam layanan TBC pada RS di bawah jaringan masing-masing serta solusi yang dapat dilakukan.
8. Mengarahkan RS jaringan untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan kab/kota di wilayah masing-masing jika mengalami Kendala dalam layanan TBC, termasuk terkait jejaring internal dan eksternal, pemeriksaan TCM, akses logistik OAT dan non-OAT, dan hal-hal lainnya terkait layanan TBC, termasuk untuk mendapatkan OJT dari dinas kesehatan kab/kota jika dibutuhkan.

9. Mengirimkan surat umpan balik kepada Tim Kerja TBC, Kementerian Kesehatan terkait update data RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang memiliki SK Tim TBC, Standar Prosedur Operasional (SPO) program TBC, telah mendapatkan peningkatan kapasitas, serta melakukan integrasi SIMRS-SITB.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nurul Badriyah (Hp 0812 4906 4906) atau Sdri. Kartika (Hp 0857 7361 8960).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Penyakit Menular,



dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.